M. L. Z. L. Guedes, P. C. Farias, L. C. M. Farias, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Distribuição dos serviços de verificação de óbito no Brasil: análise da implementação da rede nacional frente à previsão normativa

M. L. Z. L. Guedes[a], P. C. Farias[b], L. C. M. Farias[c]

[a]IGPRS - Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul (RS), Brasil
[b]ABRAMEL - Associação Brasileira de Médicos-Legistas, Brasil
[c]UCPEL - Universidade Católica de Pelotas, , Pelotas (RS), Brasil
[*]Endereço de e-mail para correspondência: dra.mizini@yahoo.com.br Tel.: +55-53-995521094

Palavras-chave: Serviço de Verificação de Óbito; Mortalidade; Vigilância em Saúde; Medicina Legal; Sistema de Informação em Saúde.

1. INTRODUÇÃO

A vigilância do óbito no Brasil constitui componente essencial das ações em saúde pública, sendo responsável pela produção de informações fundamentais para o planejamento, monitoramento e avaliação de políticas de saúde. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), essa organização é orientada pela Lei nº 8.080/1990.

Os Serviços de Verificação de Óbito (SVO) desempenham papel central na elucidação de mortes naturais sem causa definida, permitindo a adequada determinação da causa básica de morte e contribuindo para a qualificação das estatísticas de mortalidade. Estudos nacionais demonstram que a atuação desses serviços está associada à redução de causas mal definidas e ao aprimoramento da vigilância epidemiológica.

Com o objetivo de estruturar essa atividade, foi instituída, por meio da Portaria nº 1.405/2006, a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa Mortis (RNSVO), com previsão de implantação progressiva de serviços distribuídos entre as unidades federativas, além de organização por níveis de complexidade.

Apesar desse planejamento normativo, a distribuição efetiva dos SVO no território nacional ainda apresenta lacunas. Nesse contexto, torna-se relevante analisar a implementação da rede frente à capacidade prevista, considerando suas implicações para a vigilância em saúde e para o sistema médico-legal.

2. OBJETIVO

Avaliar a distribuição dos Serviços de Verificação de Óbito no Brasil, comparando a capacidade de implantação prevista na normativa com a presença de serviços cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

3. METODOLOGIA

Trata-se de estudo descritivo, de abordagem quantitativa, baseado em dados secundários.

Foram identificados todos os Serviços de Verificação de Óbito cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), com extração realizada em abril de 2026. Para cada unidade federativa, foram analisadas a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com referência em 1º de julho de 2025, o número de SVO previstos conforme a Portaria nº 1.405/2006 e o número de serviços efetivamente registrados.

Foi realizada análise descritiva da distribuição dos SVO no território nacional, com comparação entre a capacidade normativa de implantação e a disponibilidade real dos serviços.

4. RESULTADOS

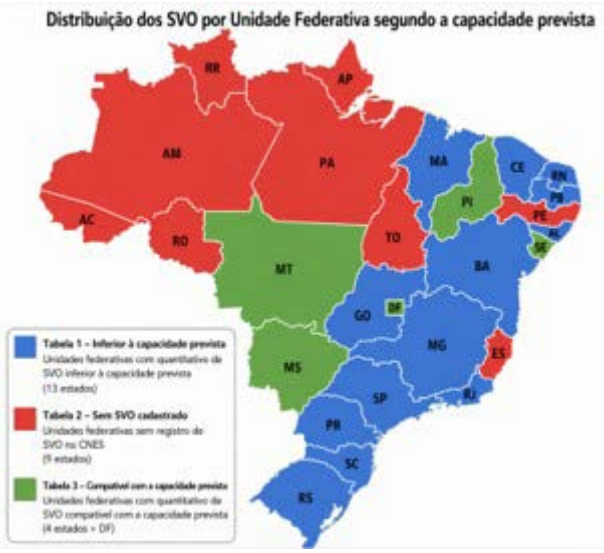
Foram identificados Serviços de Verificação de Óbito em 18 unidades federativas, enquanto 9 estados não

apresentaram serviços cadastrados. Observou-se distribuição heterogênea, com concentração em regiões mais desenvolvidas e predominância em capitais.

Entre os estados com SVO, verificou-se variação no número de serviços, com maior concentração em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. A maioria dos serviços está localizada em capitais ou municípios de maior porte, embora também tenham sido identificados serviços em municípios do interior.

Das 27 capitais brasileiras, apenas 14 dispõem de SVO em seu território, enquanto 11 não possuem o serviço local. Em alguns estados, a cobertura ocorre de forma regionalizada, com serviços localizados fora da capital.

A análise comparativa entre capacidade prevista e serviços implantados evidenciou subdimensionamento da rede em diversas unidades federativas. Estados como Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul apresentam cobertura inferior a 25% da capacidade prevista, com valores aproximados de 16,7%, 20% e 25%, respectivamente. Em Minas Gerais, a cobertura é de aproximadamente 57%, enquanto Paraná e Santa Catarina apresentam cerca de 50%. O Ceará apresenta cobertura de 66,7%.



5. DISCUSSÃO

Os achados evidenciam descompasso entre o planejamento normativo da Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e sua implementação efetiva, indicando limitações na consolidação dessa política pública. A persistência de lacunas sugere influência de fatores relacionados à implementação, como organização regional, pactuação interfederativa e priorização de recursos.

A insuficiência de SVO impacta diretamente a qualidade das informações de mortalidade, favorecendo a manutenção de causas mal definidas e comprometendo a vigilância epidemiológica. Além disso, reduz a capacidade de detecção de eventos relevantes em saúde pública.

No âmbito assistencial, a ausência desses serviços transfere ao médico assistente a responsabilidade pela certificação do óbito em contextos de incerteza diagnóstica, podendo resultar em registros imprecisos.

Destaca-se, ainda, a repercussão sobre os Institutos Médico-Legais (IML), com o encaminhamento indevido de mortes naturais sem elucidação diagnóstica. Esse deslocamento de demanda gera sobrecarga operacional, desvio de finalidade institucional e potencial prejuízo à atividade pericial criminal.

A distribuição desigual dos serviços evidencia disparidades regionais e reforça a necessidade de fortalecimento da rede.

6. CONCLUSÃO

A distribuição dos Serviços de Verificação de Óbito no Brasil é desigual e inferior à capacidade prevista, evidenciando subdimensionamento da rede em diferentes regiões do país.

A ampliação e qualificação desses serviços são fundamentais para a melhoria da qualidade das informações de mortalidade, para o fortalecimento da vigilância em saúde e para a adequada organização dos fluxos assistenciais e periciais, evitando o encaminhamento indevido de mortes naturais aos Institutos Médico-Legais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. 1990 set 20.

[2] Cardoso ABC. Serviços de verificação de óbitos: características e contribuições para o esclarecimento de causas de morte [dissertação]. Curitiba: Universidade Federal do Paraná; 2003.

[3] Dias PHP. Análise da Rede Nacional dos Serviços de Verificação de Óbito (RNSVO): a partir da criação de indicadores de desempenho para o serviço [dissertação]. Brasília: Fundação Oswaldo Cruz; 2024.

[4] Camurça Correia Pinto CH, Ibiapina Gurgel MG, Santos Alves MD, de Lima Passos ML, Antunes Nunes Diniz S, Rodrigues da Conceição M. Investigação de óbitos por causas mal definidas: estratégia de fortalecimento da vigilância em saúde. Rev Rene. 2012;13(4):871–879.

[5] Rozman MA, Eluf-Neto J. Necropsia e mortalidade por causa mal definida no Estado de São Paulo. Rev Panam Salud Publica. 2006;20(5):307–313.

[6] França E, Teixeira R, Ishitani L, Duncan BB, Cortez-Escalante JJ, Morais Neto OL, et al. Redistribuição das causas mal definidas de óbito no Brasil, 2000–2010. Rev Saude Publica. 2014;48(4):671–681. doi:10.1590/S0034-8910.2014048005146.

[7] Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.405, de 29 de junho de 2006. Diário Oficial da União. 2006 jun 30.

[8] Brasil. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) [Internet]. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br. Acesso em: 2026.

[9] Brasil. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) [Internet]. Disponível em: https://cnes.datasus.gov.br. Acesso em: 2026.

[3] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas da população residente para os municípios e para as unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2025. Rio de Janeiro: IBGE; 2025